

AFMCP Chapter 2 — 한국어 전문 번역

GOTOIT 임상 방법과 Gather·Organize 단계

IFM AFMCP 과정 | 한국어 번역본

강의 1: GOTOIT 임상 방법 소개 (Dr. Kelechi Uduhiri)

좋은 하루 되세요, Applying Functional Medicine in Clinical Practice의 이 섹션에 오신 것을 환영합니다. 이것은 GOTOIT입니다. 여기서 여러분은 기능의학 임상 방법의 6단계를 배우게 될 것입니다. 저는 IFM 의학 교육 이사 Dr. Kelechi Uduhiri입니다.

기능의학 인증 역량에 근거를 두는 것이 매우 중요합니다. 첫 번째 단계는 환자 커뮤니케이션입니다. 우리는 각 환자에게 의미와 목적을 부여하는 것이 무엇인지 식별하고 이 정보를 임상 결정에 반영하고자 합니다. 이것은 협력적인 경험임을 진정으로 담아내고 있습니다. 치료적 관계를 구축하는 것입니다.

근본 원인을 어떻게 평가하고 합성하는가? GOTOIT 모델을 사용합니다. 선행요인(antecedents) — 'ante'는 '이전'을 의미합니다. 환자의 현재 건강 상태에 대한 선행요인. 이전에 무슨 일이 있었는가? 태아기에 무슨 일이 있었는가? 이 문제로 이어진 중요한 과거 건강 사건이나 행동, 상황은 무엇인가?

촉발요인(triggers) — 빠르게 작용하는 근본 원인. 노출, 중요한 과거 및 현재 생활 사건, 행동과 습관을 포함합니다. 무엇이 이 환자의 건강 문제를 촉발하고 있는가?

매개요인(mediaiators) — 무엇이 계속 진행되게 하는가? 근본 원인을 영속화하는 현재 진행 중인 요인들은 무엇인가?

GOTOIT 6단계: G(수집) — 임상적 만남 전에 자신을 정돈하고, 환자의 관점에서 선행요인·촉발요인·매개요인을 수집하는 상세한 기능의학 병력을 취합니다.

O(정리) — 수집한 환자 데이터를 IFM 타임라인과 매트릭스에 정리합니다. 이를 통해 근본 원인을 식별하고 개인화합니다.

T(전달) — 이야기를 환자에게 다시 전달하여 정확하고 상호 이해가 공유되는지 확인합니다. 치료적 관계와 파트너십을 구축하는 단계입니다.

O(순서) — 지금 할 수 있는 것을 우선순위에 따라 협력적으로 결정합니다. 환자에게 무엇이 중요한가? 건강을 위해 무엇을 원하는가?

I(시작) — 어떤 중재를 시작할 것인가? 진단과 예후를 평가하고, 협력 팀의 다른 구성원에게 의뢰할 수도 있습니다.

T(추적) — 중재의 효과를 추적하고 모니터링합니다. 권고 사항을 준수할 수 있는가? 중재를 조정하고 개선합니다.

전통적 접근법에서는 환자가 질병 진단을 받고 거기서 멈춥니다. 기능의학 접근법에서는 진단부터 시작하고, GOTOIT 임상 프레임워크를 추가하여 기능 장애를 식별하고 근본 원인을 다룹니다.

강의 2: Gather 단계 — 수집의 기술 (Dr. James Carter Jr.)

안녕하세요, Dr. James Carter Jr.입니다. 오늘은 기능의학을 핵심 기술과 방법을 사용하여 실천하는 방법에 대해 이야기하겠습니다. 환자의 이야기를 수집하고 이를 사용하여 기능의학 타임라인을 개발하는 것입니다.

GOTOIT Gather 단계의 두 가지 핵심 요소: ① 환자 만남 준비를 위한 개인적 실천(자신을 수집하기) ② 이전 훈련과 다른 방식의 상세한 기능의학 병력 취하기.

자신을 수집할 때는 마음챙김 기술을 사용합니다. 여러 출처에서 정보를 수집합니다: 접수 양식, 설문지, 환자와의 초기 접촉, 신체 검사.

저는 매우 바쁜 의사였습니다. 각 환자 방에 뛰어들어야 한다고 생각했습니다. 시간이 지남에 따라 이것이 환자의 이야기에 현재할 수 없게 한다는 것을 알게 되었습니다.

이제 저는 멈춥니다. 깊은 숨을 쉽니다. 이전 대화를 옆으로 치웁니다. 손 씻기를 잠시 멈추는 순간으로 사용합니다. 깊은 호흡, 손 씻기 의식, 감사 표현 — 다양한 방법으로 자신을 준비할 수 있습니다.

마음챙김 명상을 연습하면 부정적인 입력을 줄이고 더 창의적이고 분석적이 될 수 있게 해줍니다. 불안이 줄어들고, 진정이 되며, 더 공감할 수 있고, 다른 사람의 관점을 의사결정에 통합할 수 있습니다.

공감적 경청은 동기부여 면담의 핵심 부분입니다. 환자의 이야기를 완전히 듣는 것입니다.

무의식적 편향 완화: 자신을 수집하는 것은 암묵적이고 무의식적 편향을 완화하는 데 도움이 됩니다. Daniel Kahneman의 'Thinking, Fast and Slow'는 시스템 1 사고(빠르고 자동적)와 시스템 2 사고(의도적이고 분석적)를 설명합니다. 마음챙김 활동을 할 때 시스템 2로 전환하려고 합니다.

강의 3: Gather 단계 — 기능의학 타임라인과 ATMs

기능의학 타임라인에 집중하겠습니다. 이 도구는 환자 삶의 중요한 건강 사건들을 지도화할 수 있는 임상 현장 도구입니다. 환자의 삶은 정보로 가득합니다. 우리가 그 정보를 수집하고 처리하고 문서화할 방법을 찾는다면 환자를 도울 수 있는 기회를 가질 수 있습니다.

타임라인의 구조: 임신 전부터 출생 전, 출생, 현재 우려 사항까지. 왼쪽에는 임상 소견(진단, 수술, 검사결과, 투약, 알러지), 오른쪽에는 선행요인·촉발요인·매개요인을 기록합니다.

선행요인(Antecedents): 유전되거나 후천적으로 획득된 소인 요인. 영향은 수개월에서 수년 지연됩니다. 예: ApoE4 대립유전자, 가족력, 불면증, 좌식 생활, 항생제, 부정적 감정. 일부 유전된 선행요인은 후성유전학적 중재로 조절 가능합니다.

촉발요인(Triggers): 초 단위에서 수주 이내에 생리적 기능 장애를 활성화하는 단일 에피소드 또는 반복적 노출. 예: 촉발 음식, 알러젠, 사고, 외상, 수술, 환경 노출, 감염. '그 사건을 경험한 이후로 건강이 예전 같지 않습니다.'

매개요인(Mediators): 증상, 기능 장애 및/또는 질병에 기여하고 영속화하는 현재 진행 중인 요인. 환자의 치유와 회복을 방해합니다. 식이, 환경 독소, 정신사회적 스트레스 요인, 복용 중인 약물·보충제에 집중합니다.

수집 도구: 성인 접수 설문지, 식이·영양·생활방식 일지, 의학적 증상 설문지(MSQ), PROMIS.

임상 흐름 경로: 만남 전 차트 검토가 최적. 시간 부족 시 핵심 질문 활용. 선행요인 질문: '가족 중 어떤 질환이 있나요? 제왕절개로 태어났나요? 모유 수유를 받았나요?' 촉발요인 질문: '그 이후로 건강이 예전 같지 않다면, 그 사건은 무엇인가요?' 매개요인 질문: '집/직장에서 무슨 일이 있나요?'

강의 4: 패널 — Gather 단계와 무의식적 편향 완화 (Dr. Carter & Dr. Chandra)

이 세션에서는 Dr. James Carter, Dr. Arti Chandra와 함께 패널 형식의 질의응답을 진행합니다. GOTOIT 수집 단계와 암묵적 편향 완화 방법에 대해 이야기합니다.

Dr. Carter: 임상 공간에 들어가기 전에 멈추는 것이 뇌를 재설정하는 데 도움이 됩니다. 진료실 문 밖에 서서 깊은 숨을 몇 번 쉬고, 환자 앞에서의 경험이 어떨지 시각화합니다. 자동적인 반응이 들어오면 다른 구획에 넣고 옆으로 치웁니다.

Dr. Chandra: 방문 후 정화 호흡을 합니다. 다음 환자를 위해 열린 슬레이트, 깨끗하고 따뜻한 마음을 유지합니다. 환자를 '동료 인간'으로 생각하며 진료실에 들어갑니다.

편향 사례 (Dr. Chandra): 가정 폭력 상황에서 가해자인 남편과 피해자인 아내 모두의 가정의였습니다. 화가 났음에도 개방성과 연민을 가지고 접근하여, 분노 관리 워크숍과 정신 건강 치료에 동의하도록 도울 수 있었습니다.

편향 사례 (Dr. Carter): 분노를 표현하며 들어온 환자. 자동 반응을 멈추고 환자를 가까운 가족으로 상상하며 재구성했습니다. 방문의 90%를 연결에 사용하고 마지막 5분에 임상 계획을 세웠습니다. 그 환자는 '아무도 그런 방식으로 나에게 연결하려 하지 않았다'며 진료를 계속하게 되었습니다.

자원: 하버드 암묵적 편향 도구, 'Thinking, Fast and Slow' (Kahneman), 다양한 배경의 사람들과의 커뮤니티 연결, 편향이 영향을 미쳤던 3가지 사례 자기 성찰 연습.

강의 5: Organize 단계 — 기능의학 매트릭스 활용법

환영합니다. 이제 GOTOIT 임상 방법의 두 번째 단계, Organize(정리) 단계로 넘어갑니다. 핵심 도구는 기능의학 매트릭스(IFM Matrix)입니다.

Organize 단계의 정의: 단순히 병력을 취하고 진단하는 것과 다릅니다. 기능 장애의 근본 원인을 식별하고, 시스템 생물학적 방식으로 생각하며, IFM 매트릭스에 기록하는 것입니다. 이것은 환자 평가 방식을 근본적으로 변화시킵니다.

핵심 관점 전환: 기존 의학에서는 '증상 → 진단 → 치료'의 기관 기반 접근법을 사용했습니다. 기능의학에서는 '질병의 감별 진단'에서 '기능 장애의 감별 진단'으로 전환합니다. 만성 질환의 복잡성을 줄이고 표적화된 접근법을 만들어낼 수 있습니다.

매트릭스의 구조: ① 왼쪽 패널: ATMs(선행·촉발·매개요인) ② 하단: 수정 가능한 생활방식 요인(수면, 신체 활동, 영양, 스트레스, 관계) ③ 7개 노드: 7개 생리적 기능 영역 ④ 중심: 정신·감정·영적 요소.

7개 노드의 상호연결: 장 내 이상균총(dysbiosis) → 장 투과성 증가 → 면역계 과활성화(방어·수복 노드). 만성 염증 → 과도한 산화 스트레스 → 미토콘드리아 기능 장애(에너지 노드). 독소 완화·제거에는 많은 에너지 필요 → 미토콘드리아 기능 장애가 독소 처리 방해. 특정 독소 → 심혈관 질환(수송 노드). 인슐린은 호르몬이자 신호 분자로 여러 장기에 작용(커뮤니케이션 노드). 호르몬 → 골 구조와 지방 조직 영향(구조적 무결성 노드).

타임라인에서 매트릭스로 데이터 이전: ① 임상 소견(진단, 증상, 검사결과) → 매트릭스 7개 노드에 배치 ② ATMs → 매트릭스 왼쪽 패널에 배치 ③ 정신·감정·영적 요소 → ATMs에도 포함 가능 ④ 생활방식 요인 → 주로 매개요인으로 하단에 배치. 동일한 데이터가 매트릭스의 여러 섹션에 배치될 수 있습니다.

'잉크가 어디에 있는가(Where's the ink?)': 매트릭스를 채웠을 때 잉크가 가장 많이 모이는 곳이 치료의 우선순위를 알려줍니다. 환자 상태의 가장 중요한 근본 원인 기여 요인이 무엇인지 파악할 수 있습니다.

3가지 환자 유형별 매트릭스 활용: 환자 A(건강 유지 원하는 환자) — 아직 표현되지 않은 잠재적 ATMs와 생활방식 요인을 식별, 정밀 예방 의학 제공. 환자 B(진단되지 않은 증상군 환자) — 증상 분포로 근본 원인 설명 생성, 진단 없이도 기능 장애 파악. 환자 C(복합 만성 질환 환자) — 알려진 진단을 노드에 배치해 패턴 파악, 근본 원인 개입 개발.

임상 흐름 경로: 타임라인의 ATMs와 임상 소견을 매트릭스로 이전 → 수정 가능한 생활방식 요인과 정신·감정·영적 요소 추가 → 환자 상태의 근본 원인 설명 생성 → 다음 단계(Tell, Order)를 위한 준비.

강의 6: 창립자 패널 — 타임라인과 매트릭스 활용 조언 (Dr. Michael Stone & Dr. Bob Roundtree)

여러분, 특별 패널 발표를 소개합니다. Dr. Michael Stone과 Dr. Bob Roundtree — 타임라인과 매트릭스를 직접 개발한 창립자들입니다. 새로운 학습자들이 이 도구를 어떻게 활용할지 조언을 들어보겠습니다.

기능의학의 핵심 차이점 (Dr. Roundtree): 일반 의학 훈련과 다른 점은 '지연 발병 질환(delayed onset disease)'의 개념입니다. 배경 요인, 선행요인, 촉발요인이 환자가 문제를 겪기 수십 년 전부터 시작되었을 수 있습니다. 갑자기 자가면역질환이 생긴 환자는 '지난 주에 무엇을 했는가?'라고 묻지만, 실제로는 아동기부터 시작된 촉발요인이 있을 수 있습니다.

타임라인의 기원: Dr. Sidney Baker(예일대 소아과)가 처음 제안했습니다. 그는 광범위한 타임라인 개념을 도입했습니다 — 지난 주가 아닌 평생의 타임라인, 심지어 출생 전 단계까지 포함. 기능의학 타임라인은 일생의 타임라인으로 식이, 환경 건강, 스트레스 등 모든 요소를 포함합니다.

Dr. Stone의 실천 팁: 시작점은 '마지막으로 건강했던 때가 언제였나요?'라고 묻는 것입니다. 그 시점이 20년 전이거나 어린 시절일 수 있습니다. 고혈압의 경우, 태아기에 작게 또는 일찍 태어난 것과 연결될 수 있습니다. 만성 질환을 볼 때는 기능의학 타임라인 렌즈로 '언제 시작되었는가'를 고려해야 합니다.

매트릭스의 탄생 (Dr. Stone): 초기 AFMCP에서 강의의 다른 부분들을 연결하는 방법을 찾다가 종이 한 장에 각 부분의 연결을 그리기 시작했습니다. David Jones가 이것을 보고 '바로 이것이다'라고

했고, 당일 타이핑해서 가져와 케이스 청취에 사용했습니다. 매트릭스는 기관 시스템 중심 사고에서 시스템 네트워크와 생리학 중심 사고로의 전환을 가능하게 합니다. 타임라인과 매트릭스를 함께 사용하면 환자의 건강/질병을 3차원, 4차원으로 볼 수 있습니다.

Dr. Roundtree의 보완 조언: 기능의학을 실천한다는 소문이 나면, 주류 의사에게 무시당하거나 간단한 치료만 받은 환자들이 찾아옵니다. 그들이 긴 증상 목록을 가져옵니다. 매트릭스는 이 정보를 '노이즈'가 아닌 '시그널'로 바꿔줍니다. 장 문제인가? 면역 문제인가? 환경 독소에 의한 문제인가? — 매트릭스가 정보 조직화를 도와줍니다.

처음 시작하는 학습자를 위한 조언 (Dr. Stone): '지금 있는 곳에서 시작하라, 되고 싶은 곳이 아닌'. 처음에는 이해하기 어려운 환자 한 명을 선택해 타임라인을 사용해 보세요. 다음 방문에서 매트릭스를 작성해 보세요.

Dr. Roundtree의 격려: 처음에는 느릴 것입니다. 무엇이 관련이 있는지 모를 것입니다 — 괜찮습니다. 그냥 채워나가세요. 시간이 지남에 따라 패턴이 명확해지고 효율적인 과정이 될 것입니다. 궁극적인 목표는 형식 없이 머릿속에서 자연스럽게 이루어지는 것입니다. 그것은 몇 년이 걸릴 수 있습니다.

코스 학습 전략: GOTOIT 6단계는 마치 6코스 정찬 메뉴와 같습니다. 한 번에 한 코스씩 할 수 있습니다. 짧은 진료 시간에도 한 방문에 한 단계씩 진행하면 결과가 여전히 더 좋습니다. 자신에게도 이 과정을 적용해 보세요 — 내 수면, 영양, 운동, 관계, 스트레스 관리는 어떤가요? 진료 중에는 기존에 보는 검사들(CMP, CBC, hs-CRP, 지질 패널)을 기능의학 렌즈로 새롭게 바라보세요.

강의 7: 임상 실천 요령 — 매트릭스를 활용하는 법 (Dr. Elyaman)

안녕하세요 여러분. 저는 일찍 기능의학을 접할 수 있어서 행운이었습니다. 기능의학 실천가가 되기 전에는 자연적이거나 전인적인 것들에 매우 비판적이었습니다 — 그것이 제가 훈련받은 방식이었으니까요. 하지만 저를 설득한 것은 바로 매트릭스였습니다.

기능의학 이전: 질병을 찾아볼 때 병태생리학은 완전히 건너뛰고 '어떻게 진단하고 치료하는가'만 봤습니다. 기능의학과 매트릭스를 사용하게 된 이후에는: 환자가 실제로 어떤 내재적 불균형을 갖고 있는지 볼 수 있게 되었습니다. 이제 가장 먼저 병태생리학부터 봅니다.

매트릭스 활용 방법: 물리적으로 매트릭스를 작성합니다 — 질환, 불균형, 증상, ATMs 기록, 하단에 생활방식 요소 채우기. 7개 불균형을 살펴보고 가장 큰 2개 불균형을 원으로 표시하고 환자에게 보여주며 그 시스템부터 작업합니다. 기능의학의 아름다운 점: 하나의 시스템을 개선하면 많은 다른 시스템들도 좋아지기 시작합니다.

전자의무기록(EMR) 통합 방법: 매트릭스를 '검사 결과'로 스캔해서 차트에 입력합니다. 이전 매트릭스를 언제든지 확인할 수 있습니다. HPI(현재 병력)에 생활방식 요소들을 추적하기 위한 질문들을 포함시킵니다 — 영양, 관계 등.

임상 변화: 기능의학 이전에는 어떻게 해야 할지 몰랐던 환자들이 있었습니다. 매트릭스를 사용하게 된 후: 내재적 불균형을 이해하고 해당 시스템을 지원하는 방법을 알게 되었습니다. 매트릭스 하단의 수면, 운동, 관계에 집중합니다. 모든 환자에게 운동 처방, 관계 처방, 수면 처방이 필요할 수 있습니다. 복잡한 케이스들이 더 명확하고 집중적이며 개인화된 방식으로 해결됩니다.

새로운 학습자에게: 처음으로 매트릭스를 배우고 있다면, 두려워하지 마세요. 천천히 연습을 시작하세요. 이것을 하고 있다는 사실 자체가 다른 많은 의료 제공자들보다 더 많은 것을 하고 있다는 의미입니다. 지금 여러분이 가진 가장 강력한 도구를 즐기세요.